

口服避孕药与其它药物相互作用

071000 中国人民解放军第252医院 杨振平 刘 宁 马 富

目前临床采用多种形式,多种途径搞好计划生育。

临床上除使用一些器具避孕之外,更多的是使用药物避孕。当今临床应用的药物多属于口服避孕药或阴道放置药物,而这类大多数为甾体化合物,总的说来甾体避孕药是行之有效的。但在人们服用过程中,也难免因患某些疾病而同服一些药物,而出现避孕失败的现象。

1. 与抗结核类药物同服。如利福平是一种很强的肝微粒体药物代谢酶的诱导剂,它增强口服甾体避孕药(包括雌激素样物质和孕激素样物质)在肝内的代谢,引起血中浓度降低。应用利福平治疗结核时,可使服避孕药妇女月经周期失去控制,引起突破性出血率增加,并易导致避孕失败而妊娠。然而对非口服避孕药剂没有这样的相互作用。

2. 与抗癫痫药物同服。如苯巴比妥、去氧苯巴比妥、扑痫酮、乙琥胺等药物为肝药酶诱导剂,可促进甾体激素的代谢,使同服抗癫痫药和甾体避孕药的妇女突破性出血率和避孕失败率增高。苯妥英钠与口服避孕药合用,可引起体液潴留,促进癫痫复发或加重,并降低口服避孕药的作用,引起避孕失败。

3. 与抗生素同服。如氯霉素、氨苄青霉素、红霉素、呋喃妥因等广谱抗生素长期口服,抑制肠道细菌生长繁殖,可减少甾体激素的肝肠循环。特别是对雌激素,使血中的药物浓度降低而减弱口服避孕药的效果。

4. 与镇痛药和安定药。在口服甾体避孕药时,同服含有非那西汀或吡唑酮类的解热镇痛药和氨甲丙二酯、利眠宁等安定药均可使避孕失败。如去甲羟安定以与葡萄糖醛酸结合形式排出体外,口服避孕药反而促其排出。有报导表明,服用口服避孕药可促进扑热息痛在体内的排出,是因避孕药提高了扑热息痛与葡萄糖醛酸结合能力,所以为了达到同等药效,服用避孕药妇女应适当加大扑热息痛的用量。

5. 口服避孕药降低了抗凝血药、降血糖药和降压药的药理作用。如双香豆素类抑制体内凝血酶原和凝血因子Ⅲ的合成,雌激素药物能使凝血因子

增加,可降低双香豆素的抗凝血作用。因此二者合用,必须增加抗凝血药物的剂量。

6. 同服解痉药,可使口服避孕药妇女,易引起突破性出血和妊娠。

7. 口服甾体避孕药与三环抗抑郁药合用时,可能由于这两类药物在肝脏中竞争共同的代谢酶,因而使三环抗抑郁药代谢减慢,故应适当减低剂量。如对丙咪嗪有相对耐药性,易发生毒副作用,如昏睡、恶心、头痛等。

8. 与维生素类:(1)服用甾体避孕药妇女血浆中维生素A水平有明显增高,但尚未见报导达到中毒水平(300 μ g/100ml)。如停药后维生素A的水平仍然持续升高,若接着就怀孕,从而有造成致畸胎的危险性。(2)口服含有雌激素避孕药妇女,可使体内维生素B₆代谢紊乱,维生素B₆血浆水平降低,可诱发精神抑郁症,应及时补充维生素B₆,可使其精神抑郁症状得到缓解。(3)长期服用混合型甾体避孕药时,也能导致维生素B₁₂的血浆浓度降低。通常在正常情况下无临床重要性,但在部分营养不良的病人,不能排除出现血液学改变的可能。(4)长期口服避孕药的妇女体内叶酸代谢异常,表现为血清叶酸水平降低,而且红细胞叶酸水平也降低。(5)维生素C可增强口服甾体避孕药的作用。服用1g维生素C时,比单独服避孕药的同一人其血浆乙炔雌二醇的浓度明显升高。主要是维生素C能使低剂量雌激素转变为高剂量的雌激素的结果。

9. 口服避孕药可改变血清铁、铜、锌的含量,也可以改变金属蛋白即运铁球蛋白、血浆铜蓝蛋白、 α_2 -巨球蛋白和白蛋白的含量。

10. 吸烟可使口服避孕药者增加患心血管疾病的危险性。对口服避孕药的妇女,应停止吸烟或选择其它避孕方法。

综上所述,笔者认为口服避孕药可干扰其它药物的作用,更重要的是其它药物也可以导致口服避孕药失败。所以服用避孕药的妇女选择口服避孕药时避免与影响避孕效果的药物伍用,因某些疾病,确需服用某些药物治疗时,最好不选用口服避孕方法。